

Bilan de suivi d'un patient hypertendu

ESMS | Suivi biologique, traitements et situations intercurrentes

Suivi recommandé

- **Consultation** : tous les 3 à 6 mois si PA contrôlée.
- **Na, K, créatinine/DFG + recherche de protéinurie** : tous les 1 à 2 ans; plus souvent chez le sujet âgé et si diabète, MRC, protéinurie, HTA mal contrôlée, IC ou événement intercurrent.
- **Sans diabète ni dyslipidémie** : glycémie à jeun + EAL environ tous les 3 ans.

Ordonnance biologique - HTA stable

- Na, K
- Créatinine + DFG CKD-EPI
- Recherche de protéinurie (méthode selon contexte/laboratoire)

Après introduction / majoration IEC - ARA2 - diurétique - ARM

- Na / K / créatinine : contrôle selon la molécule et son RCP, généralement dans les semaines suivant la modification.
- Puis : fréquence adaptée à la stabilité clinique et biologique.
- Contrôle rapide en cas de déshydratation, diarrhée/vomissements, hypotension, chute, infection, AINS ou altération aiguë.

Point de rigueur

- Le RAC n'est pas à imposer comme examen HTA de routine dans l'ancienne fiche HAS/SFHTA 2016 (sauf diabète non protéinurique).
- La HAS 2023 recommande en revanche créatinine + RAC pour le dépistage ciblé annuel de MRC chez les personnes à risque : appliquer cette stratégie si le patient relève du dépistage MRC.